PROTOCOLO CLÍNICO PARA LA ACTIVACIÓN DE LA RUTA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Sharon Acuña	Líder Ginecología	27-05-25
VALIDÓ	Leidy Yibeth Toledo Rojas	Referente Clínico GPC y protocolos	30-05-25
APROBÓ	Karin Milena Gamba F.	Subgerente científico	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
   2.1. Objetivo General 4
   2.2. Objetivos Específicos 4
3. ALCANCE 4
4. METODOLOGÍA 5
   4.1 Pregunta/s PICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
   4.2 Búsqueda y selección de la literatura ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES 6
6. RECOMENDACIONES y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 12
7. ALGORITMO 12
8. BIBLIOGRAFÍA 31
9. ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

1. INTRODUCCIÓN

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un procedimiento médico y legal que permite a la mujer o persona gestante decidir sobre la continuidad del embarazo bajo condiciones específicas reconocidas por la normatividad colombiana. De acuerdo con la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, la IVE es legal en Colombia bajo tres causales: (1) cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud física, mental o social de la mujer o persona gestante, (2) en casos de grave malformación del feto incompatible con la vida, y (3) cuando el embarazo es resultado de violencia sexual, incesto o inseminación no consentida. Posteriormente, la Sentencia C-055 de 2022 amplió el acceso libre a la IVE hasta la semana 24 de gestación. A partir de esa edad gestacional, sólo se permite bajo las tres causales ya mencionadas.

En el ámbito nacional, las cifras disponibles muestran una persistente necesidad de garantizar el acceso oportuno y seguro a la IVE. La falta de atención integral y el desconocimiento de las rutas legales y clínicas aumentan el riesgo de complicaciones médicas, estigmatización y barreras institucionales. A nivel institucional, el Hospital Regional de Moniquirá ha identificado la necesidad de fortalecer los procesos asistenciales en salud sexual y reproductiva, mediante un protocolo claro que oriente a los equipos de salud en la atención segura, ética y oportuna de las solicitudes de IVE.

Este protocolo se justifica como una herramienta indispensable para estandarizar el abordaje clínico, legal y administrativo de la IVE, garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes. Responde a la necesidad de brindar atención humanizada y sin dilaciones, en concordancia con la normativa vigente, particularmente la Resolución 051 de 2023, que modifica el Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal (Resolución 3280 de 2018), aplicable especialmente a gestaciones mayores de 24 semanas.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Orientar la atención integral para la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres en edad fértil atendidas en el Hospital Regional de Moniquirá con base a lo establecido por la normatividad vigente.

2.2. Objetivos Específicos

1. Fortalecer el entrenamiento a profesionales de la salud en técnicas modernas de interrupción voluntaria del embarazo y su aplicación de acuerdo con las normas vigentes, las condiciones de la mujer que lo solicita y el proceso de gestación.
2. Reconocer y actualizar red de prestadores de EAPB para referenciación según sea el caso particular de riesgo de la mujer que solicita IVE.
3. Implementar y ejecutar el modelo de atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la ESE Hospital Regional Moniquirá en mujeres con embarazo hasta 15 semanas de gestación

3. ALCANCE

Este protocolo se aplicará en todas las áreas asistenciales del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. en donde se brinde atención a mujeres que manifiesten su voluntad de interrumpir voluntariamente el embarazo. Cubre servicios como consulta externa, urgencias Y hospitalización, así como los procesos administrativos relacionados con las autorizaciones. Tiene como finalidad unificar el abordaje institucional para garantizar una atención integral, oportuna, segura y con enfoque de derechos, en cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional vigente.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

El protocolo está orientado a todo el talento humano en salud que participa en la atención directa o indirecta de personas gestantes, incluyendo médicos generales y especialistas (especialmente ginecobstetras y médicos generales), profesionales de enfermería, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo, personal de referencia y contrarreferencia, y coordinadores de servicios asistenciales. Todos estos actores deberán conocer y aplicar las rutas y procedimientos definidos en este documento para asegurar la calidad y continuidad del cuidado.

La población objetivo de aplicación de este protocolo son mujeres en edad fértil, sin distinción de identidad de género, orientación sexual, etnia, nacionalidad o situación migratoria, que soliciten voluntariamente la interrupción del embarazo. Se consideran tanto los casos en los que la solicitud ocurre antes de la semana 24 de gestación, como aquellos posteriores, siempre que se cumpla alguna de las tres causales definidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. Este protocolo también contempla la atención de personas menores de 14 años, en quienes se presume violencia sexual según lo establecido en la Ley 1719 de 2014.

4. METODOLOGÍA

La elaboración de este protocolo se basa en el análisis y recopilación normativa de los principales lineamientos legales y técnicos que regulan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. Entre los documentos centrales que fundamentan este protocolo se encuentran la Sentencia C-355 de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias específicas, la Sentencia C-055 de 2022, que amplió el acceso libre a la IVE hasta la semana 24 de gestación, y la Resolución 051 de 2023, la cual modificó el numeral 4.2 del Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal (RIA), adoptado previamente mediante la Resolución 3280 de 2018.

Estas normas definen el marco legal y operativo para garantizar el acceso oportuno, seguro y digno a este derecho fundamental en salud. A partir de estos documentos, el Hospital

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Regional de Moniquirá E.S.E. compiló, organizó y adaptó la información con el objetivo de facilitar su comprensión y aplicación por parte de todo el personal de salud involucrado en el proceso de atención. Se buscó traducir las disposiciones normativas en procedimientos claros, éticos y basados en la evidencia, que permitan al talento humano actuar de forma coherente con los principios de legalidad, confidencialidad, enfoque de derechos, y atención centrada en la persona.

El contenido de este protocolo ha sido estructurado para responder a las necesidades operativas del hospital, garantizando que los equipos de trabajo cuenten con herramientas prácticas para el abordaje adecuado de cada caso, tanto en el ámbito clínico como administrativo.

Para el hospital regional de Moniquirá la activación del protocolo de IVE se le asignará el código institucional **"Código Violeta"**.

4. MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia se fundamenta en tres pilares normativos principales: la Sentencia C-355 de 2006, la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, y la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. Estos instrumentos definen las condiciones legales, éticas y operativas para garantizar el acceso seguro, oportuno y respetuoso al derecho a interrumpir un embarazo, especialmente en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La Sentencia C-355 de 2006 despenalizó parcialmente el aborto en Colombia al establecer tres circunstancias en las cuales no se incurre en delito al interrumpir voluntariamente un embarazo: (1) cuando la continuación del embarazo representa un riesgo para la vida o la salud física, mental o social de la mujer o persona gestante, certificado por personal médico o de psicología; (2) cuando se detecta una malformación fetal grave incompatible con la vida, determinada por un profesional de la salud; y (3) cuando el embarazo es resultado de una

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

conducta delictiva como acceso carnal sin consentimiento, abuso sexual, inseminación artificial no consentida o incesto, sin requerir que exista denuncia previa.

Posteriormente, la **Sentencia C-055 de 2022** amplió el marco de protección de los derechos sexuales y reproductivos al despenalizar completamente la IVE **hasta la semana 24 de gestación**, sin que sea necesario acreditar alguna de las causales mencionadas. Esta decisión reconoce que la normativa previa generaba barreras desproporcionadas, afectaba el acceso equitativo a los servicios de salud y vulneraba derechos fundamentales como la dignidad, la autonomía y la salud integral de las mujeres. A partir de la semana 24, se mantienen vigentes las tres causales establecidas por la Sentencia C-355 de 2006.

En complemento, la **Resolución 051 de 2023** del Ministerio de Salud modifica el numeral 4.2 del Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptado por la Resolución 3280 de 2018, incorporando directrices operativas específicas para la atención de embarazos mayores a las 24 semanas. Este instrumento establece que, en esos casos, se debe aplicar estrictamente el contenido del artículo 7, que retoma las causales de la Sentencia C-355 y exige que toda decisión sea tomada bajo criterios clínicos, éticos y de respeto por los derechos humanos.

En el Hospital Regional de Moniquirá, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se realiza hasta la semana 15 de gestación, siempre que se cuente con las condiciones técnicas y humanas necesarias. En los casos en los que la solicitud se presente después de la semana 15, se procederá con la **remisión inmediata a una institución de nivel III**, en el mismo momento en que se reciba la manifestación de voluntad de la paciente.

Cuando la solicitud se realiza con una edad gestacional superior a las **24 semanas**, se deberá tener en cuenta la presencia de alguna de las **tres causales definidas por la Sentencia C-355 de 2006** de la Corte Constitucional, las cuales permiten la IVE en cualquier momento del embarazo.

Si alguna de las causales de interrupción voluntaria del embarazo no ha sido previamente denunciadas, es deber del Hospital Regional de Moniquirá, o el personal que designe la institución, dar aviso del hecho a las autoridades competentes.

información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1719 de 2014, la atención en salud para las víctimas de violencia sexual debe brindarse independientemente de la existencia de denuncia penal. Igual tratamiento se dará frente al acceso carnal a menores de 14 años el cual se presume, en todos los casos, como una conducta de violencia sexual.

Las atenciones y procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo en este protocolo se prestarán a partir de la manifestación de la voluntad de la niña, adolescente, mujer o persona gestante. incluye a toda persona con capacidad biológica de quedar en embarazo y atravesar el proceso de gestación, lo que abarca,hombres transgénero, mujeres cisgenero , mujeres transgenero , personal transmasculinas , personas no binarias o personas intersexuales, sin excluir otras identidades de género con las cuales la persona se auto reconozca con capacidad de gestar

La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se considera esencial y de carácter urgente, por lo tanto, siempre se deberá llevar a cabo de forma inmediata. Sólo en casos excepcionales y justificados, se podrá prever un plazo máximo de hasta cinco (5) días calendario contados a partir de la manifestación de voluntad que haga la persona gestante para interrumpir el embarazo en el primer contacto que tenga con el servicio de salud. De dicha manifestación se dejará registro en la historia clínica de la paciente.

ID	Término	Definición	Fuente
1	Interrupción voluntaria del embarazo	Es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue reconocido como tal por la corte constitucional colombiana mediante la sentencia c-355 de 2006, en tres circunstancias. La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es el procedimiento donde se busca terminar de manera consciente el embarazo en curso, en condiciones seguras.	Organización mundial de la salud, OMS

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

2	Derechos Sexuales y reproductivos	Son ciertos derechos humanos internacionalmente reconocidos, que garantizan el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual y reproductiva y la convivencia sexual. Son derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación y que permiten adoptar libremente decisiones sobre su cuerpo su sexualidad y su vida.	Protocolos para la atención de enfermería a la salud sexual y reproductiva de la mujer. MSPS 2014
3	Consentimiento informado	Manifestación libre y voluntaria de la mujer embarazada en la que solicita y acepta someterse a una IVE, para la cual debe haber recibido información clara, real, objetiva y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los riesgos y los efectos para su salud y su vida. Este consentimiento deberá suscribirse con antelación al procedimiento de IVE y anexarse a la historia clínica.	Resolución 3280 de 2018 Minsalud
	Objeción de conciencia	La objeción de conciencia es un derecho personalísimo que responde a manifestaciones íntimas relacionadas con convicciones morales, filosóficas o religiosas de las personas. La Corte Constitucional ha reconocido que únicamente las personas naturales que estén involucradas directamente en la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo pueden ejercerlo. Por ello se excluye de este al personal administrativo, de enfermería o personal judicial. Tampoco aplica para instituciones nipuede realizarse de forma colectiva.	Corte Constitucional Sentencias C-355 de 2006, la T- 209 de 2008 y la T-388 de 2009
	Enfoque diferencial	Reconoce las particularidades de las poblaciones y condiciones sociales y territoriales que ubican a las personas en situaciones de marginalidad y de mayor vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la salud.	Resolución 2626 de 2019 Minsalud

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	Rutas Integrales de atención en salud-RIAS	Son una herramienta obligatoria que definen a los integrantes del sector salud y de los demás sectores, las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención de salud a partir de acciones de autocuidado, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y cuidados paliativos.	Resolución 3280 de 2018 Minsalud
	Atención integral en salud	Conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos	Resolución 3280 de 2018 Minsalud
	Información en salud	Acciones de producción, organización y difusión de un conjunto de datos o mensajes para orientar, advertir, anunciar o recomendar a las mujeres con intención reproductiva a corto plazo, gestantes, mujeres en puerperio, familias, comunidades, organizaciones y redes, así como a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores sobre aspectos relacionados con el fomento de la salud, la detección de riesgos y la acción ante su aparición, lo cual contribuya al logro de los resultados en salud esperados para esta población.	Resolución 3280 2018. Ministerio d e salud y protección social.
	Ruta de atención materno-perinatal	La ruta integral de atención en salud materno perinatal es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, que define a los integrantes del sector salud (Dirección Territorial de Salud, aseguradores, entidades a cargo de regímenes especiales o de excepción y prestadores) las condiciones necesarias para garantizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la generación de una cultura del cuidado	Resolución 3280 de 2018 Minsalud

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		para todas las personas, familias y comunidades, como parte de la garantía del ese derecho fundamental. El objetivo de esta ruta es establecer las disposiciones técnicas y operativas de obligatorio cumplimiento para la prestación de la atención en salud a todos los recién nacidos y mujeres, durante la etapa preconcepcional, la gestación, el periodo perinatal y el posparto.	
	Consentimiento sustituto	Es la manifestación informada, libre, y voluntaria para que dé lugar un acto asistencial por parte de quienes se encuentran en ejercicio de los derechos de patria potestad en los casos en los cuales el niño, niña o adolescente no pueda participar en el proceso de toma de decisiones, dar su asentimiento o consentimiento, por razones de derivadas del no desarrollo de su autonomía progresiva y contextual o debido a su condición clínica. El consentimiento sustituto, no se traduce en un poder absoluto y en la toma de decisiones en salud. A través de este, el niño, niña o adolescente tiene derecho a que las decisiones se tomen en el marco de su mejor interés, esto es con el fin de garantizar el ejercicio y el goce efectivo del derecho a la salud y mejorar sus condiciones de salud hacia el futuro.	Resolución 309 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social
	Asentimiento Pediátrico	Se entiende como la manifestación informada, libre, voluntaria que emiten niñas, niños, y adolescentes, de aceptar que dé lugar un acto asistencial. El asentimiento informado, es resultado del proceso de información realizado conforme su nivel de desarrollo acerca de la naturaleza de su condición, y busca promover el ejercicio a la autonomía progresiva y contextual para participar en los procesos de toma de decisiones en salud y enfermedad que le afectan, promoviendo su capacidad moral y desarrollo emocional Tiene como objeto solicitar una expresión de la voluntad del paciente para aceptar el cuidado propuesto. El asentimiento pediátrico, puede ser evaluado por medio de la identificación de la comprensión del paciente acerca de la situación y de los factores que influyen en su respuesta.	Resolución 309 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

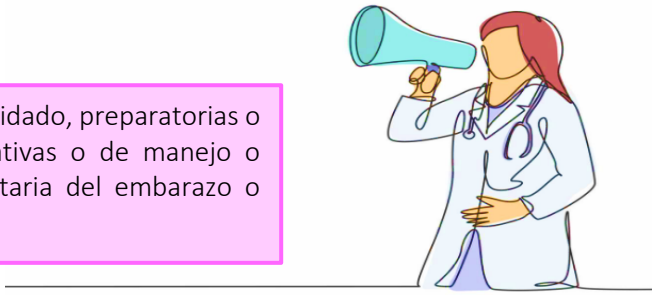
6. RECOMENDACIONES Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ID	Recomendación	Actividad/es	Observación
1	Garantizar que el personal médico, de enfermería y de orientación asignado a la atención en IVE esté debidamente capacitado y cuente con la disposición voluntaria para brindar este servicio	• Capacitar al personal médico, enfermería y orientadores en información y rutas de atención para la IVE. • Garantizar la remisión oportuna a través de la red de servicios cuando no haya médico disponible. • Verificar y asegurar la disponibilidad inmediata de insumos, medicamentos y dispositivos al momento de activar la ruta de atención.	La falta de disposición del personal puede convertirse en una barrera de acceso y generar trato inadecuado. Es clave asegurar un ambiente de respeto, confidencialidad y calidez en la atención. La disponibilidad y capacitación del personal mejora la oportunidad y calidad del servicio.

Sólo el profesional encargado de realizar directamente el procedimiento para la interrupción voluntaria del embarazo podrá objetar por razones de conciencia el cumplimiento de dicha obligación siempre que se formule por escrito expresando las razones por las cuales la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo está en contra de sus más íntimas convicciones, para lo cual no servirán formatos generales de tipo colectivo, ni aquellos que realice persona distinta a quien ejerce la objeción de conciencia y debe derivar a un profesional entrenado que no presente objeción de conciencia para continuar con la ruta de atención de la IVE.

o tienen validez. El uso de la
. Está prohibido divulgar y

En ningún caso, las personas que cumplen funciones asistenciales, de cuidado, preparatorias o posteriores a la intervención, o que cumplan funciones administrativas o de manejo o dirección, podrán negarse a que se practique la interrupción voluntaria del embarazo o demorar, obstruir, o negar el acceso a dicha atención.



ID	Recomendación	Actividad/es	Observación
2	Activar de manera inmediata la ruta de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el momento en que la mujer o persona gestante manifieste su decisión, ya sea durante la consulta externa, en los servicios de urgencias generales o en urgencias obstétricas, sin exigir la identificación de causales salvo en embarazos mayores de 24 semanas. La activación se realiza con base en su voluntad expresada mediante el consentimiento informado.	1. Consulta inicial: • Atender el primer contacto dela mujer o la persona gestante con el sistema de salud, ya sea en consulta externa, urgencias o durante hospitalización. • Asegurar que se apliquen los principios de no discriminación, confidencialidad, enfoque diferencial • Preguntar de una manera respetuosa a la mujer o la persona gestante con que nombre social o pronombre quiere ser reconocido dentro de un entorno inclusivo. • Se deben recoger datos básicos y brindar información inicial que se adapte a su idioma, su identidad de género, su contexto cultural. • Realizar el interrogatorio en un ambiente confidencial, con personal capacitado, en condiciones de seguridad. • Confirmar embarazo, determinar edad gestacional (FUM confiable) y evaluar si es intrauterino. • Reconocer y registrar la voluntad de interrumpir el embarazo.	Ver ruta de atención Se debe garantizar la disponibilidad de psicología sin que esta valoración se deba solicitar en todos los casos y convertirse en barrera para la atención y pueda ser solicitada según criterios y preferencias de la personal médico.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		• Valorar estado de salud general, riesgos y condiciones psicosociales. • Detectar presencia de violencia, coerción o afectación emocional. • Garantizar privacidad y evitar exigencias innecesarias como acompañantes no requeridos por la paciente. • Brindar información sobre los métodos de IVE y los pasos del proceso. • Garantizar autonomía para decidir entre continuar la gestación, dar en adopción o interrumpirla. • Ofrecer asesoría anticonceptiva desde el ingreso, de acuerdo con preferencias y criterios de elegibilidad OMS/CDC. adaptados al contexto de la persona (inclusivo para personas trans que pueden tener tratamientos hormonales o cirugías) • Atender con confidencialidad y sin criminalización los casos de aborto autogestionado: **En casos donde la mujer o persona gestante haya autogestionado el aborto, por ejemplo, a través de la compra informal de medicamentos o con el uso de otros métodos, las y los profesionales de la salud deben determinar si el embarazo fue interrumpido de manera exitosa y proveer a las mujeres y personas gestantes la atención necesaria para culminar este proceso de manera segura y satisfactoria, manteniendo la guarda del secreto profesional y absteniéndose de realizar cualquier tipo de denuncia**	
3	Garantizar una evaluación clínica integral en la consulta inicial para la solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que incluya anamnesis completa, examen físico dirigido y toma de paraclínicos cuando sea clínicamente indicado, sin	1. Anamnesis • Recoger y documentar antecedentes personales y familiares relevantes. • Evaluar historia reproductiva, sintomatología actual y uso previo de anticonceptivos. • Registrar claramente la solicitud de IVE y la edad gestacional estimada.	Ver ruta de atención Se debe garantizar la disponibilidad de psicología sin que esta valoración se deba solicitar en todos los casos y convertirse en barrera para la

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	generar barreras de acceso al procedimiento.	• Indagar condiciones psicosociales: tensión emocional, estado de ánimo, síntomas neurovegetativos y redes de apoyo. • En gestaciones mayores a 24 semanas, valorar la afectación emocional y social para identificar causales contempladas en la Sentencia C-355 de 2006. 2. Examen físico • Realizar examen físico general completo dentro de un ambiente de respeto y confidencialidad . • Confirmar la existencia del embarazo y estimar la edad gestacional mediante examen pélvico bimanual o medios paraclínicos disponibles. • Identificar signos clínicos sugestivos de embarazo entre la semana 6 y 8. • Evaluar discrepancias entre edad gestacional y tamaño uterino: Si el tamaño uterino es menor al esperado, debe considerarse la posibilidad de un embarazo menos avanzado que el estimado por la fecha de la última menstruación, un embarazo ectópico o un aborto retenido. Un útero mayor al esperado puede indicar un embarazo más avanzado que el calculado por la fecha de la última menstruación, un embarazo múltiple, presencia de miomas o enfermedad trofoblástica gestacional. • Verificar la posición del útero para prevenir complicaciones por aspiración endouterina por IVE • Explorar signos de infección genital y tratarlos oportunamente. • En mujeres con VIH, activar ruta institucional de atención y brindar asesoría. 3. Paraclínicos: No exigir paraclínicos como requisito para realizar la IVE. • Solicitar hemograma si se sospecha clínicamente anemia. • Conocer la hemoclasificación e indicar inmunoglobulina anti-D en mujeres Rh negativas.	atención y pueda ser solicitada según criterios y preferencias de la personal médico

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		• Ofrecer tamizaje para VIH y sífilis, explicando que son voluntarios y no condicionan el procedimiento. • En caso clínicamente justificado, realizar ecografía para descartar embarazo ectópico u otras patologías. • Informar a la mujer sobre su derecho a no visualizar la imagen ecográfica, salvo que así lo desee. • Ecografía transvaginal: No es mandatorio. Se debe solicitar si se dispone del recurso, o si la FUR no es confiable con la altura uterina o presenta riesgo de embarazo múltiple o gestación extrauterina, siempre preguntar a la paciente si desea escuchar la fetocardía, no o debe obligarse a la paciente a ver o escuchar si no lo desea • Barrido transabdominal: Puede utilizarse para evaluar la presencia de saco intrauterino y por Diámetro medio del saco se puede evaluar edad gestacional	

Certificación de las causales según la Corte Constitucional en las Sentencias C-355 de 2006

1

Primera Causal: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico.

La causal incluye no solamente el peligro para la vida de la mujer, sino también el peligro para su salud. La interpretación de la causal debe hacerse en forma amplia e integral, respetando el derecho que la mujer tiene a decidir sobre su propio cuerpo y favoreciendo el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo para toda mujer cuya vida o salud esté en riesgo.

El único requisito exigible para la IVE bajo la causal vida o salud es un certificado médico. Este puede ser expedido por cualquier médico y no necesariamente por un especialista o por el médico tratante de la mujer. Los conceptos de psicología sobre riesgo para la salud mental de la mujer no pueden ser descalificados por parte del profesional médico que evalúa el riesgo.

2

Segunda Causal: Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.

Solo se pueden considerar malformaciones fetales que sean de tal magnitud que hagan inviable la vida del feto. Malformaciones o enfermedades que puedan ser tratadas médicamente, antes o después del parto, no son procedentes para la realización de la interrupción del embarazo bajo esta causal; sin embargo, no se debe omitir la posibilidad de afectación de la salud integral de la mujer como resultado de la continuación de este embarazo.

Reproducir total o parcialmente este documento.

3	Tercera Causal: Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. La violación afecta todas las dimensiones de la salud de la mujer: La física porque el acto mismo vulnera la integridad física de la mujer, exponiéndola, al menos a dos posibles situaciones: embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual. La mental porque es frecuente que la violación y el embarazo forzado generen en la mujer una afectación emocional que puede llegar hasta la ideación suicida o el suicidio. La social porque afecta el proyecto de vida de la mujer y se originan situaciones como: pérdida de la pareja, pérdida del trabajo, temor al estigma, humillación, culpabilidad, rechazo del embarazo. La causal violación, a diferencia de las otras causales (causal salud o causal malformaciones congénitas) no se resuelve únicamente en los servicios de salud, sino que involucra otras esferas como la judicial y/o la administrativa por algún motivo —conflicto armado, amenazas, temor a represalias; se debe aceptar como causal válida para la interrupción del embarazo aquella cuyos requisitos sean menos gravosos e impliquen menor afectación para la mujer. El único requisito exigible para la interrupción del embarazo bajo la causal violación es la presentación de una copia de la denuncia debidamente formulada ante la autoridad competente. No es necesario que la mujer afectada interponga la denuncia; podrá hacerlo cualquier persona que se entere y en cualquier momento posterior a la ocurrencia de los hechos.

ID	Recomendación	Actividad/es	Observación
4	Garantizar el acceso oportuno, sin barreras administrativas ni interpretaciones restrictivas, a los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuando se configure alguna de las tres causales legales reconocidas por la Corte Constitucional. La certificación de estas causales debe realizarse de manera diligente, ética, con enfoque de derechos y sin juicios de valor por parte del personal de salud.	Revisar cuadros informativos: Certificación de las causales según la Corte Constitucional en las Sentencias C-355 de	Ver ruta de atención Se debe garantizar la disponibilidad de psicología sin que esta valoración se deba solicitar en todos los casos y convertirse en barrera para la atención y pueda ser solicitada según criterios y preferencias de la personal médico

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

5	Garantizar orientación y asesoría sin que sea obligatoria ni represente barrera	Ofrecer acompañamiento emocional y espacio de diálogo sobre decisiones, condiciones personales, familiares y sociales	No debe imponer valores ni cambiar decisiones; debe ser libre, confidencial y respetuosa
6	Disponer de profesionales capacitados para brindar la orientación	Priorizar psicología o trabajo social; si no están disponibles, puede hacerlo personal de salud capacitado en derechos sexuales y reproductivos En la valoracion se debe evaluar que la persona cuente con red de apoyo, medidas de autocuidado y se debe garantizar la posibilidad de referir a grupos de apoyo LGBTIQ+	No es prerrequisito para la atención; no debe retrasar el procedimiento
7	Realizar valoración por psicología cuando se identifiquen riesgos o se solicite	Evaluar salud mental, riesgos emocionales y sociales Definir plan de intervención y apoyo	No debe imponer valores ni cambiar decisiones; debe ser libre, confidencial y respetuosa
8	Incluir trabajo social para atención integral y abordaje de condiciones sociales	Evaluar red de apoyo; brindar acompañamiento; gestionar remisiones interinstitucionales (ICBF, entes territoriales)	Rol clave como garante de derechos y coordinador de atención integral
9	Adaptar asesoría en casos de violencia de género o vulnerabilidad	Identificar situaciones de violencia y brindar atención conforme a protocolos vigentes (como Resolución 459 de 2012)	Ofrecer rutas de denuncia e informar derechos conforme normativa nacional
10	Eliminar prácticas que retrasen o nieguen el acceso a la IVE	No exigir juntas médicas, remisiones previas, dictámenes, autorizaciones externas, ni pactos institucionales para negarse a prestar el servicio	Estas prácticas constituyen barreras de acceso y violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres
11	Garantizar que la mujer o persona gestante reciba información clara, imparcial y completa sobre las diferentes alternativas a la IVE y los procedimientos disponibles	1. Las pacientes pueden solicitar la IVE desde : • Consulta externa : se activa la ruta de atención y debe ser enviada a urgencias de ginecología e ingresar como TRIAGE 1 para el respectivo manejo.	

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	(farmacológico y no farmacológico), asegurando que pueda tomar una decisión informada y autónoma, conforme a su edad gestacional, condiciones clínicas y preferencias personales. Asegurar el uso adecuado del método farmacológico cuando sea elegido, con una correcta evaluación clínica previa y acompañamiento durante todo el proceso.	• Urgencias general : si al IVE se deriva de una atención de urgencias se debe realizar una llamada telefónica al servicio de ginecología para comentar la paciente y se dirige la paciente con el camillero para continuar la atención por el servicio de ginecología sin generar barreras ni demoras en su atención , esta será valorada por los médicos del servicio de Ginecología donde se dará solución a la petición de la IVE según protocolos • Urgencias Ginecología : Se activa Ruta de IVE según protocolo y se clasifica como TRIAGE 1 2. Durante la consulta inicial: o Brindar información clara y comprensible sobre las opciones disponibles: IVE, continuación del embarazo, y adopción. o Escuchar de forma activa los temores, dudas y expectativas de la mujer o persona gestante. o Verificar que la información ha sido comprendida antes de continuar el proceso. o Documentar este proceso en la historia clínica. 3. Consentimiento informado: o Diligenciar y firmar el consentimiento informado institucional que incluya: ✓ Opciones de tratamiento y sus implicaciones. ✓ Riesgos, ventajas y duración de cada opción. ✓ Qué esperar antes, durante y después del procedimiento. ✓ Signos de alarma. ✓ Información sobre retorno de la fertilidad, inicio de relaciones sexuales y anticoncepción postevento. En menores de 14 años: • Requiere firma de asentimiento pediátrico (NO requiere que firmen los padres para que la menor de 14 acceda a la IVE) • Si requiere realización del procedimiento AMEU o si requiere anestesia , si se le debe solicitar consentimiento de padres o adultos responsables, si la menor no desea que sus padres no sepan de la IVE

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		se debe realizar consentimiento sustituto por parte de la institución / o del ICBF 4. Elección del método: o Asegurar que la decisión final del procedimiento sea tomada libremente por la mujer, sin presiones externas, y en función de sus preferencias. o Verificar que no existan contraindicaciones clínicas para el uso del método farmacológico. Si se opta por el método farmacológico: o Confirmar edad gestacional por ecografía. o Evaluar contraindicaciones: porfirias, uso crónico de corticoides, coagulopatías o terapias con medicamentos anticoagulantes y alergias a las prostaglandinas y antiprostágenos. o Indicar el esquema más adecuado (en la institución se cuenta con mifepristona + misoprostol) o Explicar de forma verbal y escrita el uso correcto de los medicamentos, síntomas esperados y signos de alarma. o Entregar un folleto con los signos de alarma de consulta y seguimiento o Programar control posterior para verificar la resolución completa del embarazo. Si se opta por el método no farmacológico: El manejo quirúrgico con un legrado o revisión uterina de rutina no está indicada en manejo de embarazos tempranos dado que. Implica mayor dolor y alarga el proceso de aborto para las mujeres y personas gestantes, y este debe reservarse solo para los casos en los que se determine que es indispensable como en caso de retención de restos ovulares o placentaria o sangrado mayor al esperado 5. Manejo del dolor: En el método farmacológico ambulatorio se debe garantizar el uso de AINEs. Se recomienda ibuprofeno 800 mg VO 30 minutos antes del tratamiento, seguido de 400 mg VO cada 6 horas (máximo 3200 mg en 24 horas). En manejo intrahospitalario, se pueden usar antieméticos y opioides.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		6. Antibiótico: Para abortos instrumentales, los antibióticos profilácticos son obligatorios, ya que reducen significativamente el riesgo de infección. Se puede usar doxiciclina en distintos esquemas, administrada antes del procedimiento. Si hay alergia o no disponibilidad, se pueden emplear esquemas alternativos. 7. Seguimiento: Ofrecer consejería en anticoncepción, indicar cuándo retomar actividades normales, incluidos los aspectos sexuales y realizar valoración de síntomas persistente/seguimiento emocional. Solicitar control en consulta externa, evaluar sangrado, tacto vaginal y registrar hallazgos en DINÁMICA. Informar signos como sangrado >2 semanas, dolor persistente, fiebre, debilidad, etc.
	Otorgar incapacidad entre 2 a 4 semanas posterior a la IVE si es necesario.	El médico tratante debe definir la duración de la incapacidad según el caso.
	Brindar asesoría anticonceptiva previa al egreso.	• Informar sobre todos los métodos, enfatizando en los de larga duración y registrar si la usuaria decide no usar uno. • Iniciar el método anticonceptivo elegido antes del egreso. • Insertar el implante subdérmico desde el primer día de manejo farmacológico si así se elige. • Colocar el DIU tras confirmar aborto completo, si así elige (excepto en aborto séptico) • Egresar con preservativos y cita para control por planificación familiar, así elige

Tratamiento farmacológico

Antes de la semana 12 de gestación	Área: Ambulatorio Se puede llevar a cabo de manera ambulatoria desde la baja complejidad de atención. En este caso, las mujeres y personas gestantes no necesitan el acompañamiento del personal de la salud durante el uso de los medicamentos.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	No es necesaria la determinación del estatus del Rh ni ofrecer profilaxis con inmunoglobulina anti-D para embarazos menores de 12 semanas según lo previsto por la Organización Mundial de la Salud en las Directrices sobre la Atención del Aborto de 2022.
	Indicación farmacológica 1. Iniciar con 200 mg de mifepristona administrados de manera oral, a las 24 horas de administrada la mifepristona se indica manejo con 800 mcg de misoprostol vía vaginal, sublingual o bucal en dosis única. * Como mínimo deben pasar 24 horas entre la administración de la mifepristona y del misoprostol.* 2. En caso de contar únicamente con misoprostol, se pueden utilizar 800 mcg de misoprostol en dosis única suministrados por vía bucal, sublingual o vaginal. Se puede considerar la repetición de dosis de misoprostol cuando sea necesario para lograr que el proceso de aborto resulte efectivo. En las Directrices para la Atención del Aborto de la Organización Mundial de la Salud (2022) no se indica un número máximo de dosis de misoprostol. **Sin embargo, para este protocolo se considera dosis máxima de tres dosis de manejo con misoprostol (800 mcg) separado de 7 dias entre las dosis para definir posibilidad de manejo quirúrgico con AMEU**
De 12 a 15 semanas de gestación	Área: Hospitalización Se debe realizar de manera intrahospitalaria de acuerdo con las Directrices sobre la Atención del Aborto de la Organización Mundial de la Salud (2022). Las técnicas instrumentales no farmacológicas para la IVE hasta las 15 semanas de gestación también se pueden realizar desde la baja complejidad a través de la aspiración endouterina. Sin embargo, llevar a cabo la aspiración manual endouterina (AMEU) entre las 12 y las 15 semanas de gestación requiere de personal con experiencia significativa en la ejecución de esta técnica de acuerdo con lo definido en las Directrices sobre la Atención del Aborto de la Organización Mundial de la Salud (2022).
	Indicación farmacológica 1. Dosis inicial de 200 mg de mifepristona administrados de manera oral , a las 24 horas posterior a la administración de la mifepristona , administrar 400 mcg de misoprostol de manera vaginal, sublingual o bucal, cada tres horas bajo observación directa hasta la expulsión . *Como mínimo

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	deben pasar 24 horas entre la administración de la mifepristona y del misoprostol* de acuerdo con las Directrices sobre la Atención del Aborto de 2022 de la Organización Mundial de la Salud *. 2. Dependiendo de la determinación del estatus del Rh, las mujeres y personas gestantes deben recibir profilaxis con inmunoglobulina anti-D. 3. Llevar a cabo la Aspiración Endouterina (AEU) o Aspiración Manual Endouterina (AMEU). Luego de la aspiración, evaluar si el aborto fue completo a través de la inspección visual de los tejidos del embarazo y de signos de vaciamiento uterino. 4. No se debe realizar curetaje o legrado de la cavidad luego de la aspiración. 5. El personal de salud debe realizar una preparación cervical para las mujeres y personas gestantes con embarazos de 11 a 15 semanas. Si lo considera necesario, también puede realizarla para mujeres y personas gestantes con gestaciones inferiores. La preparación cervical puede ser llevada a cabo a través de las siguientes opciones: 200 mg de mifepristona administrados de manera oral entre 24 a 48 horas antes del procedimiento seguida de: 400 mcg de misoprostol sublinguales 1 a 2 horas antes del procedimiento o 400mcg de misoprostol vía vaginal 2 a 3 horas antes del procedimiento.
Después de las 15 semanas de gestación	En gestaciones de más de 15 semanas se iniciarán tramites de remisión en conjunto con los prestadores de salud la remisión de las gestantes a instituciones que realicen dicha atención después de las 15 semanas.

Regímenes de Misoprostol Solo:

- < 13 semanas: 800 mcg sublingual cada 3 horas o Vaginal/Bucal cada 3 a 12 horas (2 a 3 dosis)
- 13 a 24 semanas: 400 mcg Vía vaginal, vía sublingual o bucal cada 3 horas

Tratamiento no farmacológico o instrumentado

Las técnicas no farmacológicas o instrumentales para la interrupción del embarazo consisten en: aspiración endouterina eléctrica (AEU) o manual (AMEU) hasta las 15 semanas.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

El legrado uterino o curetaje no es un método de elección para la IVE y es una técnica obsoleta que debe dejar de ser empleada. Solamente debe ser usada cuando no hay disponibilidad de otros métodos.

<table>
<tr>
<td>Aspiración endouterina eléctrica (AEU) o manual (AMEU)</td>
<td>
La aspiración endouterina es la técnica quirúrgica de elección para embarazos hasta de 15 semanas de gestación. La aspiración consiste en la evacuación del contenido uterino a través de cánulas plásticas y un aspirador manual o eléctrico. Se caracteriza porque es un procedimiento altamente seguro y efectivo.

El instrumental básico para la AMEU incluye un aspirador manual y un juego de cánulas flexibles. Además del instrumental básico se requiere instrumental adicional (espéculo, tenáculo, dilatadores, pinzas de anillo).

Se requiere preparación del cérvix previa al AMEU, con misoprostol cuando no es posible realizar la dilatación con los dilatadores mecánicos, en adolescentes, embarazos de más de 12 semanas o cuando exista riesgo aumentado de una laceración cervical así:

<table>
<tr><th>DOSIS</th><th>VÍA</th><th>ADMINISTRACIÓN</th></tr>
<tr><td>400 MCG</td><td>Vaginal</td><td>3 horas antes de la evacuación</td></tr>
<tr><td>400 MCG</td><td>Sublingual</td><td>2 horas antes de la evacuación</td></tr>
</table>

A toda mujer se le debe administrar analgésicos antes y después del procedimiento. Olvidar esta indicación aumenta innecesariamente la ansiedad y molestia que experimenta la mujer, prolonga eventualmente el procedimiento y afecta su evolución y recuperación.

Para la profilaxis antibiótica de la técnica instrumental para la IVE se pueden considerar varios regímenes de doxiciclina teniendo en cuenta que éstos deben ser suministrados antes del procedimiento y que una dosis puede ser suficiente para evitar infecciones

Doxiciclina oral 500 mg antes del procedimiento.
Doxiciclina oral 100 mg una hora antes del procedimiento y 200 mg 1 hora y 30 minutos después de este
Doxiciclina oral 400 mg la noche (10 a 12 horas) antes del procedimiento (este régimen aumenta el riesgo de náuseas).
</td>
</tr>
</table>

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	También se puede hacer uso de esquemas terapéuticos de segunda y tercera línea en caso de alergia a la doxiciclina o cuando no se cuente con el medicamento.

ANEXOS

CODIFICACIÓN DE LA IVE DE PROCEDIMIENTOS DE IVE EN TODAS LAS EDADES GESTACIONALES– CIE-10

Para finalidad de este protocolo el Registro de la Consulta se debe hacer de la siguiente manera

• El diagnóstico principal debe corresponder al motivo de consulta manifestado por la usuaria, o en su defecto, estar vinculado con alguna de las causales legales para la IVE, como afectaciones a la salud emocional, mental o social, malformaciones fetales incompatibles con la vida o situaciones de violencia sexual

Diagnóstico marcador de IVE: El código Z30.3 debe ser registrado junto al diagnóstico principal, ya que permite identificar la atención como un procedimiento de IVE

Diagnóstico relacionado 2 (opcional): este campo puede ser utilizado a criterio del médico tratante para registrar condiciones clínicas asociadas que complementen el motivo de atención

Finalidad de la consulta en casos de IVE: Debe registrarse con el código 24, conforme a lo establecido en las Resoluciones 1036 de 2022 y 2275 de 2023

Diagnóstico principal en IVE completa: En los casos donde el procedimiento de IVE se completó, el código utilizado hace referencia al aborto médico (O045- O049).

Diagnóstico relacionado: Puede estar asociado a un síntoma o a anticoncepción postaborto (excepto el código Z303).

IVE fallida: Si el procedimiento inicial fue incompleto (aborto retenido o continuación del embarazo), se usa el código Z303 como diagnóstico secundario

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Evento	Dx Principal	Dx Relacionado	CUPS
Procedimiento después de IVE farmacológica fallida antes de las 12 semanas	**O070-O074**	**Z303**	**750302**
Procedimiento de IVE farmacológica antes de las 12 semanas	O045-O049	Z357, Z358, Z359, O350-O359, T742, Z300-Z309 (excepto Z303*)	750303
Procedimiento de IVE farmacológica después de las 12 semanas	O045-O049	Z357, Z358, Z359, O350-O359, T742, Z300-Z309 (excepto Z303*)	750303
Procedimiento de IVE farmacológica fallida después de las 12 semanas	O070-O074	Z303	750302

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Estructura de la consulta de IVE – CIE-11

Evento	Finalidad de la consulta	Causa o motivo de atención	Dx Principal	Dx Relacionado	CUPS
Consulta PyM, medicina general o enfermería	24	42	Dx según síntoma: QA49, QA04.51, LA05-LA08, LB30-LB9Y-LB9Z, JA85, 6A7Z-6A8Z	Según síntomas asociados	890201, 890205
Consulta externa, medicina general o especializada	24	42	Dx según síntoma: QA49, QA04.51, LA05-LA08, LB30-LB9Y-LB9Z, JA85, 6A7Z-6A8Z	Según síntomas asociados	890201, 890202
Consulta psicología	24	42	QA49	Dx según síntoma: QA04.51, LA05-LA08, LB30-LB9Y-LB9Z, JA85, 6A7Z-6A8Z	890208
Consulta de urgencias, medicina general o especializada	24	42	Dx según síntoma: QA49, QA04.51, LA05-LA08, LB30-LB9Y-LB9Z, JA85, 6A7Z-6A8Z	Según síntomas asociados	890701, 890702

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Estructura de procedimientos de IVE en todas las edades gestacionales– CIE-11

Evento	Vía de ingreso	Modalidad de atención	Finalidad	Dx Principal	Dx Relacionado 1	Dx Relacionado 2	CUPS
Procedimiento de IVE no farmacológica hasta las 15 semanas	02	01 a 09	24	JA00.15 a JA00.19	Códigos de extensión según la edad gestacional (Ver tabla 9)	QA49 o el relacionado según la condición médica	750302
Procedimiento después de IVE no farmacológica fallida hasta las 15 semanas	02	01 a 09	24	JA00.35 a JA00.39			750302
Procedimiento de D&E hasta las 24 semanas	02	01 a 09	24	JA00.35 a JA00.39			750303
Procedimiento después de IVE farmacológica fallida hasta las 12 semanas	02	01 a 09	24	JA00.30 a JA00.34			750302
Procedimiento de IVE farmacológica hasta las 12 semanas	02	01 a 09	24	JA00.15 a JA00.19			750302
Procedimiento de IVE farmacológica después de las 12 semanas	02	01 a 09	24	JA00.15 a JA00.19			735301 y 754101
Inducción de asistolia fetal-IAF	02	01 a 09	24	JA86.3			753733

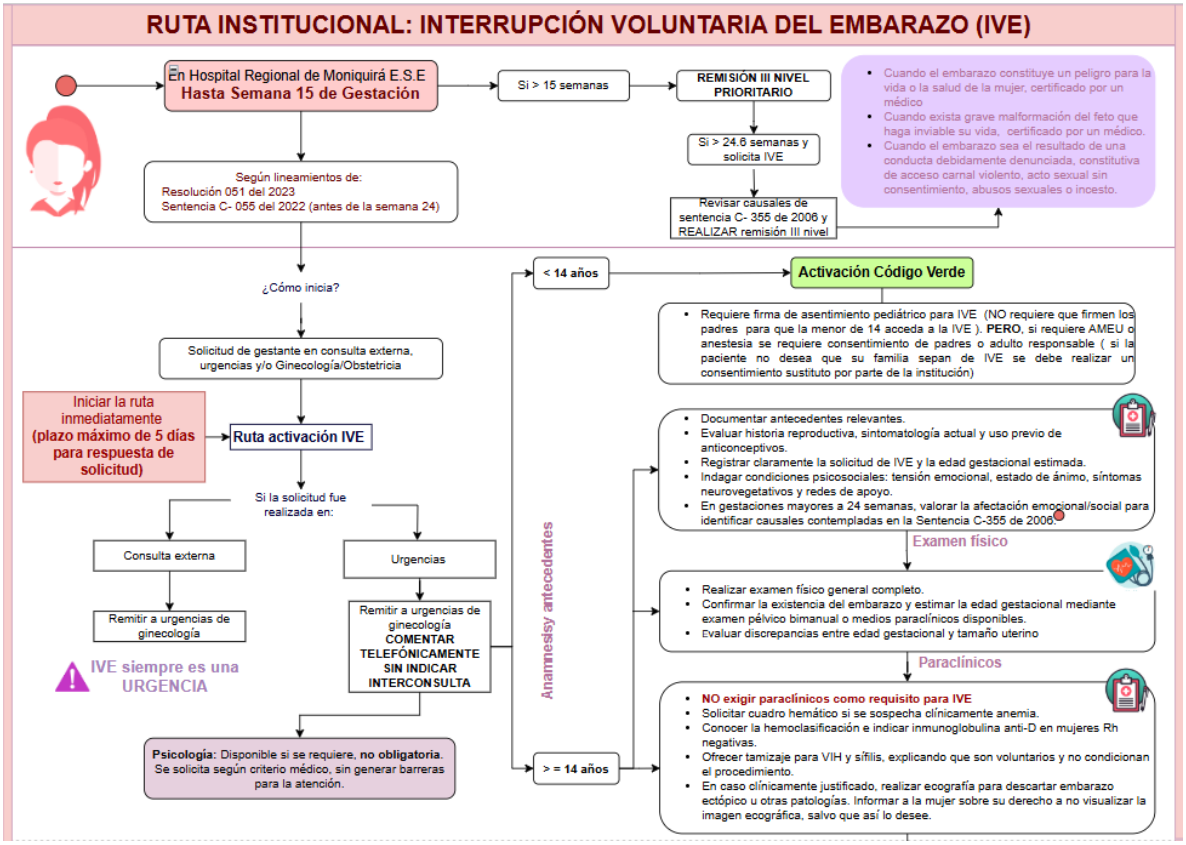
ALGORITMO

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

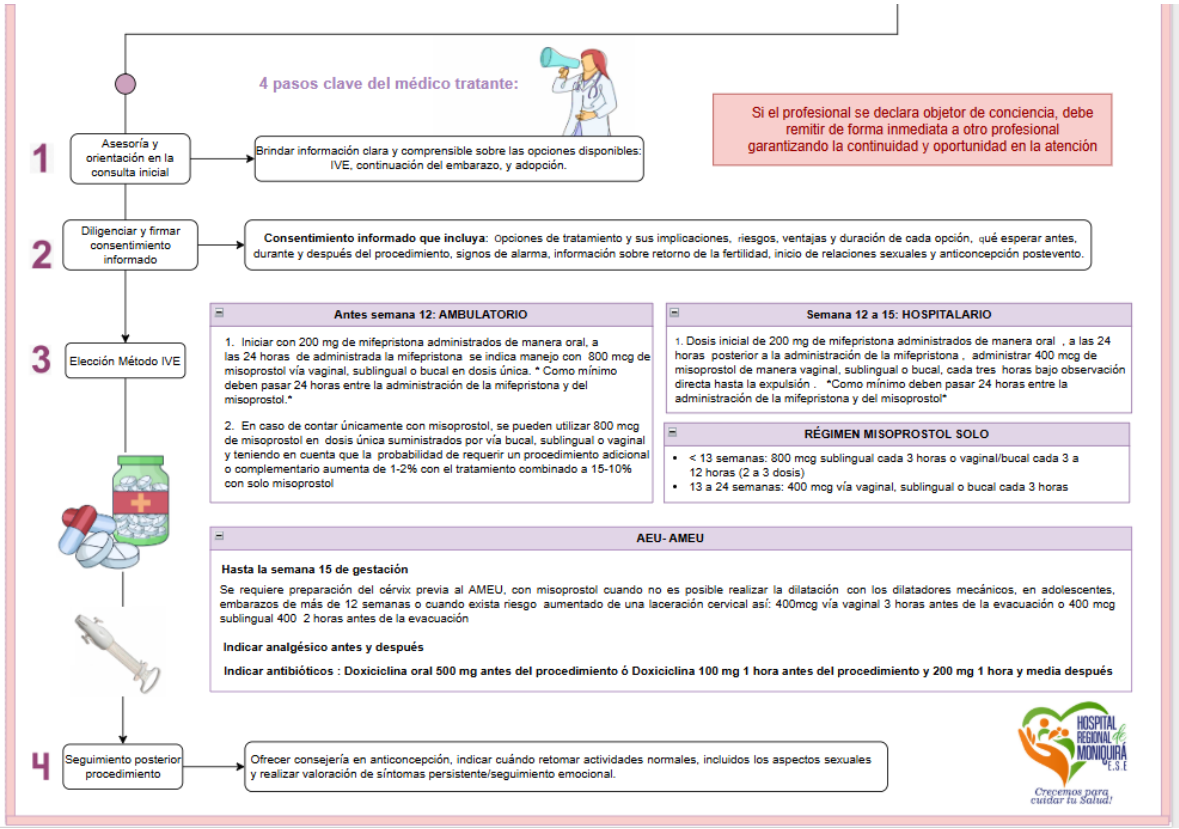
Descripción de diagnósticos en CIE-11

Código CIE-11	Descripción del diagnóstico
JA00.15	Aborto provocado completo o no especificado, complicado por infección pélvica o de los órganos genitales.
JA00.16	Aborto provocado completo o no especificado, complicado por hemorragia prolongada o excesiva.
JA00.17	Aborto provocado completo o no especificado, complicado por embolia.
JA00.18	Aborto provocado completo o no especificado, con otra complicación.
JA00.19	Aborto inducido, completo o no especificado, sin complicación.
JA00.30	Aborto médico fallido, complicado por infección pélvica o de los órganos genitales.
JA00.31	Aborto médico fallido, complicado por hemorragia prolongada o excesiva.
JA00.32	Aborto médico fallido, complicado por embolia.
JA00.33	Aborto médico fallido, complicado de otro tipo o no especificado.
JA00.34	Intento de aborto médico fallido, sin complicaciones.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.



Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.



7. BIBLIOGRAFÍA

1. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006 [Internet]. Bogotá: Corte Constitucional; 2006. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm
2. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-055 de 2022 [Internet]. Bogotá: Corte Constitucional; 2022. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/c-055-22.htm
3. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de 2018. Por la cual se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y se dictan otras disposiciones [Internet]. Bogotá: MinSalud; 2018. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%203280%20de%202018.pdf

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

4. Ministerio de Salud y Protección Social. Circular 003 de 2022. Orientaciones sobre la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la Sentencia C-055 de 2022 [Internet]. Bogotá: MinSalud; 2022. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-externa-003-de-2022.pdf

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.